

1. Introducción y relevancia clínica

La **fiebre reumática (FR)** es una **enfermedad inflamatoria sistémica** que se produce como **complicación no supurativa de una faringoamigdalitis causada por *Streptococcus pyogenes* (estreptococo β -hemolítico del grupo A)**.

Afecta principalmente a niños y adolescentes entre **5 y 15 años**, y puede comprometer **corazón, articulaciones, piel y sistema nervioso central**.

Es una enfermedad **mediada por mecanismos autoinmunes**, donde los anticuerpos generados contra antígenos estreptocócicos reaccionan de forma cruzada con tejidos del huésped (fenómeno de mimetismo molecular).

La principal consecuencia de la fiebre reumática es la **carditis reumática**, que puede causar **valvulopatías crónicas**, especialmente **estenosis mitral**, la cual sigue siendo una causa importante de enfermedad valvular en adultos jóvenes en Chile y otros países de ingresos medios.

En Chile, gracias al tratamiento antibiótico de las faringitis y a los programas de profilaxis, la incidencia ha disminuido drásticamente, pero **aún se presentan casos esporádicos**, sobre todo en zonas rurales o con acceso limitado al sistema de salud.

En el **EUNACOM**, la fiebre reumática se aborda desde dos ejes fundamentales:

- Diagnóstico clínico mediante **criterios de Jones**.
- Prevención primaria y secundaria con **penicilina**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La fiebre reumática es una reacción inflamatoria postinfecciosa secundaria a una **faringoamigdalitis estreptocócica no tratada o tratada inadecuadamente**.

2.1. Mecanismo inmunológico

- La infección por *Streptococcus pyogenes* induce la producción de **anticuerpos anti-proteína M**, una molécula de superficie bacteriana.
- Estos anticuerpos **reaccionan de manera cruzada con antígenos del tejido humano**, en particular **miocardio, válvulas cardíacas, articulaciones y sistema**

nervioso central.

- Se produce una **respuesta inflamatoria autoinmune** mediada por linfocitos T CD4+, macrófagos y anticuerpos.

2.2. Lesiones histopatológicas típicas

- **Cuerpo de Aschoff:** lesión granulomatosa característica de la carditis reumática.
- **Células de Anitschkow:** macrófagos activados con núcleo en “forma de oruga”.
- Inflamación valvular con fibrosis y calcificación progresiva (daño crónico).

2.3. Fisiopatología del daño valvular

- La carditis reumática aguda afecta principalmente la **válvula mitral** (75–80% de los casos).
- Puede causar **regurgitación en fase aguda** y evolucionar a **estenosis mitral crónica** por fibrosis y calcificación.
- La afectación aórtica es menos frecuente, y las válvulas tricúspide y pulmonar rara vez se comprometen.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Periodo de latencia

Los síntomas aparecen entre **2 y 4 semanas** después de una faringoamigdalitis estreptocócica.

No ocurre durante la infección activa, sino **posteriormente**.

3.2. Manifestaciones clínicas principales

La presentación clásica incluye fiebre, artralgia y signos de compromiso cardíaco.

Los hallazgos clínicos se agrupan según los **criterios de Jones (actualizados por la OMS y AHA 2015)**, que distinguen **criterios mayores** y **menores**.

Criterios mayores:

1. Carditis (clínica o subclínica):

- Soplo de insuficiencia mitral o aórtica.
- Cardiomegalia o signos de insuficiencia cardíaca.
- Frote pericárdico.
- Evidencia ecocardiográfica de regurgitación valvular o inflamación.

2. Poliartritis migratoria:

- Afecta grandes articulaciones (rodillas, tobillos, codos, muñecas).
- Dolor intenso, calor y tumefacción, pero sin secuelas.

3. Corea de Sydenham:

- Movimientos involuntarios, rápidos e irregulares, de cara y extremidades.
- Suele aparecer meses después del cuadro inicial.

4. Eritema marginado:

- Lesión cutánea en forma de anillos rosados con centro claro, en tronco y extremidades proximales.

5. Nódulos subcutáneos:

- Lesiones firmes e indoloras sobre superficies extensoras o tendones.

Criterios menores:

- Fiebre ($>38^{\circ}\text{C}$).
- Artralgia.
- Elevación de VSG o PCR.
- Intervalo PR prolongado en ECG.

Diagnóstico:

- Requiere evidencia de infección estreptocócica reciente (cultivo positivo o antiestreptolisinas O elevadas) **más:**
 - **2 criterios mayores, o**
 - **1 criterio mayor + 2 menores.**

Comentario EUNACOM:

El diagnóstico de fiebre reumática **no se basa solo en la clínica** ni en el antecedente de faringitis, sino en la aplicación estricta de los **criterios de Jones**.

3.3. Manifestaciones por órgano

A. Cardíacas

- Taquicardia desproporcionada a la fiebre.
- Soplo apical holosistólico (insuficiencia mitral).
- Soplo diastólico (aórtico) si hay afectación valvular doble.
- Signos de insuficiencia cardíaca: disnea, ortopnea, edemas, hepatomegalia.

B. Articulares

- Artritis migratoria de grandes articulaciones, muy dolorosa, sin secuelas.
- Mejora rápidamente con salicilatos.

C. Neurológicas (corea)

- Movimientos involuntarios, inestabilidad emocional, disartria.
- Más frecuente en niñas y adolescentes.
- Puede aparecer hasta 6 meses después del episodio infeccioso.

D. Cutáneas

- Eritema marginado y nódulos subcutáneos (poco frecuentes, pero muy específicos).
-

3.4. Diagnóstico diferencial

- **Artritis séptica:** monoartritis, sin antecedente de faringitis.
 - **Lupus eritematoso sistémico:** compromiso articular y cardíaco, ANA positivo.
 - **Endocarditis infecciosa:** fiebre prolongada, hemocultivos positivos.
 - **Artritis reactiva:** posterior a infección urinaria o gastrointestinal.
-

4. Exámenes complementarios

4.1. Confirmación de infección estreptocócica

- **Test rápido de detección de antígeno estreptocócico.**
- **Cultivo de exudado faríngeo (gold standard).**
- **Antiestreptolisina O (ASO):** título elevado >250 UI/mL confirma infección reciente.
- **Anti-DNasa B:** útil si la ASO es negativa.

4.2. Laboratorio general

- VSG y PCR elevadas.
- Leucocitosis moderada.
- Prolongación del intervalo PR en ECG.

4.3. Ecocardiografía

- Detecta regurgitación valvular subclínica (criterio diagnóstico actual).
 - Evalúa función ventricular y presencia de pericarditis.
-

5. Tratamiento (según MINSAL y OMS 2023)

El tratamiento se orienta a tres objetivos:

1. Eliminar el *Streptococcus pyogenes*.
 2. Controlar la inflamación.
 3. Prevenir recurrencias.
-

5.1. Erradicación del estreptococo

Primera línea:

- **Penicilina benzatina G intramuscular** (1,2 millones UI en adultos; 600.000 UI en niños <30 kg), dosis única.

Alternativas:

- Penicilina oral (V) 500 mg cada 8 h por 10 días.
 - En alergia: eritromicina o azitromicina por 10 días.
-

5.2. Tratamiento antiinflamatorio

- **Salicilatos (ácido acetilsalicílico):**

Dosis: 80–100 mg/kg/día fraccionado cada 6 h, hasta resolución de síntomas y normalización de reactantes.

- **Corticoides:**

Indicados en carditis moderada o grave con insuficiencia cardíaca.

Prednisona 1–2 mg/kg/día, reduciendo progresivamente en 2–3 semanas.

5.3. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca

- Reposo absoluto.
- Diuréticos (furosemida).

- Inhibidores de la ECA y digoxina si es necesario.
-

5.4. Profilaxis secundaria

Prevención de recurrencias mediante antibióticos prolongados:

- **Penicilina benzatina G intramuscular cada 3–4 semanas** (1,2 millones UI en adultos).
 - Sin carditis: durante 5 años o hasta los 21 años.
 - Con carditis sin secuelas: 10 años o hasta los 25 años.
 - Con valvulopatía residual: de por vida.

Comentario EUNACOM:

El uso correcto de **penicilina benzatina mensual** es la clave de la prevención secundaria.

5.5. Profilaxis primaria

Tratamiento adecuado de toda faringoamigdalitis estreptocócica con penicilina por 10 días.

Es la medida más efectiva para prevenir la fiebre reumática.

6. Complicaciones

- **Carditis reumática crónica:** estenosis mitral, insuficiencia mitral, regurgitación aórtica.
 - **Insuficiencia cardíaca congestiva.**
 - **Arritmias.**
 - **Pericarditis constrictiva (rara).**
 - **Recurrencias frecuentes en ausencia de profilaxis.**
-

7. Pronóstico

Depende del grado de compromiso cardíaco.

- Sin carditis: pronóstico excelente.
- Con carditis leve: buena evolución si hay tratamiento oportuno.
- Con carditis severa: puede dejar valvulopatía crónica e insuficiencia cardíaca.

La profilaxis antibiótica reduce significativamente la recurrencia y la progresión del daño valvular.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La fiebre reumática aparece **2–4 semanas después** de una faringoamigdalitis estreptocócica.
2. El diagnóstico se realiza con **criterios de Jones + evidencia de infección estreptocócica**.
3. La **carditis** es la manifestación más grave y define el pronóstico.
4. La **penicilina benzatina mensual** es la profilaxis secundaria más eficaz.
5. La **corea de Sydenham** puede presentarse meses después del episodio inicial.
6. La **artritis migratoria de grandes articulaciones** es el signo más frecuente.
7. En EUNACOM, las preguntas suelen centrarse en los **criterios diagnósticos y el esquema de profilaxis**.

Errores comunes:

- Diagnosticar fiebre reumática sin documentar infección estreptocócica.
- Suspender la profilaxis antes del tiempo recomendado.
- Usar AINEs en lugar de salicilatos como tratamiento antiinflamatorio inicial.
- Omitir evaluación ecocardiográfica.

- Confundir fiebre reumática con artritis reactiva.

9. Resumen final (6 ideas clave)

1. La **fiebre reumática** es una complicación inflamatoria autoinmune postestreptocócica.
2. Se diagnostica mediante **criterios de Jones** más evidencia de infección estreptocócica reciente.
3. La **carditis reumática** es la manifestación más grave y determina el pronóstico.
4. El tratamiento incluye **penicilina** (erradicación y profilaxis) y **salicilatos o corticoides** según la severidad.
5. La **profilaxis secundaria con penicilina mensual** previene recurrencias y valvulopatías.
6. En **EUNACOM**, los temas más evaluados son:
 - Criterios de Jones.
 - Profilaxis primaria y secundaria.
 - Manifestaciones cardíacas.